法国临床效益评价对我国创新药医保目录动态调整的启示*

赵华婷①，颜建周①，邵 蓉①

摘 要 通过介绍法国的临床效益评价，尤其是法国临床效益评价结果对医保准入的影响，进而选取典型案例阐述如何做出具体品种的评价结果和如何据此做出医保准入决定，以期为我国创新药医保目录动态调整提供思路与启示。

关键词 临床效益评价；医保目录；动态调整；法国

中图分类号 R1-9；R95 文献标志码 B 文章编号 1003-0743(2019)05-0094-03 DOI 10.7664/CHE20190524

The Enlightenment of French Clinical Benefit Evaluation on the Dynamic Adjustment of Medical Insurance Catalogue for Innovative Medicine in China/ZHAO Hua-ting, YAN Jian-zhou, SHAO Rong//Chinese Health Economics, 2019,38(5):94-96

Abstract It mainly introduced the clinical benefit evaluation of France, and focused on the impact of clinical benefit evaluation results on medical insurance access. On this basis, the typical cases were selected to explain how to make the evaluation results of specific varieties and how to make medical insurance access decisions accordingly so as to provide ideas and enlightenment for the dynamic adjustment of medical insurance catalogue for innovative medicine in China.

Key words clinical benefit evaluation; medical insurance catalog; dynamic adjustment; France

First-author's address The Research Center of National Drug Policy & Ecosystem, China Pharmaceutical University, Nanjing, 211198, China

Corresponding author SHAO Rong, E-mail: shaorong118@163.com

法国是药品创新大国，拥有较为完备的医疗保障体系。1998年起，法国就通过临床效益评价，建立了以临床疗效为核心的医保补偿体系，使得医保药品目录调整更加科学、避免了医保基金浪费。因此，本研究以法国的临床效益评价为研究对象，探讨其评价运作模式，以期为我国医保药品目录动态调整机制的建立提供启示与借鉴。

1 法国临床效益评价介绍

1.1 评价机构

法国的药品监管职能分散在卫生部、社会保障部和财政部，其下设机构各司其职。国家健康产品卫生安全局负责药品上市、卫生高级权利机构负责药品临床效益评价、卫生服务产品经济委员会负责药品定价与决定是否纳入偿付、国家补充性医疗保险基金联盟负责目录内药品偿付标准。负责具体事务部门的职能与人员组成如表1所示。

1.2 评价过程

申请药品上市时，首先由国家健康产品卫生安全局下属的上市许可委员会根据质量、安全和疗效3个指标对药品的作用和副作用进行评审。得到上市许可后，由卫生高级权利机构下属的透明委员会对药品进行SMR和ASMR评价，卫生服务产品经济委员会根据ASMR确定药品价格和决定是否列入补偿目录，国家补充性医疗保险基金联盟则根据SMR制定目录内药品费用偿付标准。SMR和ASMR每5年重新评估，药品定价和偿付标准相应调整（表2）。具体评估流程如图1所示。

1.3 评价结果

1.3.1 SMR结果的运用。法国UNCAM根据疾病严重程度和SMR级别制定药品费用偿付比例，通常包含0、35%、65%和100%四种，并且有5%的增减调整范围（表3）[2-3]。

1.3.2 ASMR结果的运用。根据ASMR，新上市药品被划分为创新药品（ASMR I-ASMR III）和常规药品（ASMR IV-ASMR V），CEPS对其分别使用外部参考定价程序和内部参考定价程序方法[5]，并参考药商提供的价格进行定价。对于ASMR I-ASMR III的药品，可以制定比参考药品更高的价格，但不得高于英国、意大利、德国和西班牙外部参考价格的平均值；对于ASMR IV的药品，若该药的仿制药即将上市，则CEPS认为该药品负担可承受，准予纳入医保，其他ASMR IV的药品根据患病人群和价格优势谈判确定价格和决定是否纳入报销目录；对于ASMR V药品，只有价格低于参考药品才能进入正面报销目录（表4）。

2 典型案例

Vemurafenib（Zelboraf®）是治疗不可切除或转移黑色素瘤BRAFV600E突变的创新药，该药品在法国的评价报告于2012年10月3日正式发布。

该报告主要包括以下几个方面：(1) 评估背景，主要是Vemurafenib的上市信息，该药品通过临时使用授权

* 基金项目：2015 年度国家社科基金重大项目（第二批）（15ZDB167）；中国药科大学“双一流”学科创新团队建设项目（CPU2018GY39）。

① 中国药科大学 国家药物政策与医药产业经济研究中心 南京 211198

作者简介：赵华婷（1994-），女，硕士在读；研究方向：医药政策与法规；E-mail: 15189807820@163.com。

通信作者：邵蓉，E-mail: shaorong118@163.com。

表 1　法国药品管理相关部门的职责与组成

相关部门	隶属部门	职责	组成
国家健康产品卫生安全局	卫生部	上市许可，广告管理和合理用药监管	上市许可委员会、药品监督委员会、广告管理和合理用药指导委员会
透明委员会	卫生高级权利机构设立的独立第三方机构	药品临床效益水平（service médical rendu, SMR）和临床效益改善程度（amélioratio du service médical ren2du, ASMR）等级定期回顾；制定合理用药指导原则和电子处方软件使用资格的认证等	28 名成员，由医生、药剂师、方法学及流行病学、患者、消费者协会等组成，来自社会保障部、卫生部、护理部、医疗保险基金、健康产品卫生安全局的 7 名成员提供咨询
卫生服务产品经济委员会	社会保障部	参考 ASMR 评价结果和药商提交的价格，与药品产业协会协商确定偿付目录内药品定价；评估药品上市后销售情况，超过预期的要求提供折扣 / 降价；成本 – 效用分析	1 名主席和副主席（独立的专家），来自社会事务部、财政部、卫生部、工业部的代表各 1 名，医疗保险代表 2 名，其他强制性医疗保险代表 1 名，补充和私人险代表 1 名，医院董事会和研发部代表各 1 名（无表决权）
国家补充性医疗保险基金联盟	财政部	根据 SMR 分级确定药品的补偿比率，并根据国家卫生支出预算和透明委员会的重评结果进行调整	法国三大社会保险机构

表 2　药品临床效益评价种类的含义、评价标准和评价结果

评价种类	含义	评价标准	评价结果
SMR 评价	评价具体临床价值，包括医疗价值、公共卫生效益和目标人群三个方面	(1) 疾病的严重程度，对发病率和死亡率的影响 (2) 药品的临床疗效 / 安全性和有效性 (3) 药物作用：治疗、预防或诊断 (4) 该药品疗法在所有治疗方案中的地位 (5) 对公共卫生方面的影响，如疾病负担、社区健康影响、临床实验结果的可推广性等	(1) 重大 (2) 中等 (3) 较弱 (4) 无附加效益
ASMR 评价	评价较参比制剂或治疗方案增加的临床效益	(1) 药品的治疗领域 (2) 药品的疗效和副作用	(1) 重大 (ASMR I)：新的治疗领域，降低死亡率 (2) 重要 (ASMR II)：疗效明显改善和 / 或副作用明显减低 (3) 中等 (ASMR III)：疗效中等程度改善和 / 或副作用减低 (4) 较小 (ASMR IV)：效益很小程度改善 (5) 无改善 (ASMR V)：效益无改善

（temporary usage authorisation, TUA）上市；(2) 药品特征，包括有效成分、适应症、剂量；(3) 类似品，包括参比制剂、相似治疗功效的药品；(4) 已有数据分析，从研究方法、数据处理角度对药品的疗效和副作用展开分析并形成结论；(5) 透明委员会结论，包括SMR、ASMR评定结果、治疗用途、目标人群和透明委员会建议。

2.1　SMR 评价

考虑到以下几点，最终Vemurafenib的SMR评价为重大：(1) 黑色素瘤是一种高转移潜能、致命性强的皮肤癌；(2) 据“癌症计划2009-2013”，改善这部分患者管理是公共卫生需求；(3) 其公共卫生负担中等（约160,000 DALYs），晚期黑色素瘤（不可切除或转移）所带来负担很小；(4) 在疾病的这个阶段几乎没有替代药物。

2.2　ASMR 评价

考虑到中位总生存期和无进展生存期的改善、安全概况（特别强调第二原发性皮肤癌的风险增加）、药品的目标性质，透明委员会认为，Vemurafenib治疗不可切除或转移黑色素瘤的BRAFV600E突变的临床效益改善程度为中等，即ASMR III。

2.3　经济性评价和价格

尽管法国要求在临床效益评估时考虑经济性，但在Vemurafenib评价报告中并未涉及到成本-效果或成本-效用等经济性评估内容，或者对该药品而言经济性评估结果是保密的。

结合ASMR评价等级并经过与经济委员会协商，Vemurafenib在法国的价格定为228 898欧元；由于其SMR评价等级为重大且属于30种慢性高诊疗费疾病、部分严重疾病或并发症超过6个月的疾病之一，报销比例定为100%[6]。

3　法国临床效益评价对我国的启示

3.1　将临床价值作为医保决策的依据

法国按照SMR和ASMR评定结果确定能否纳入医保及医保支付比例，具有较强的科学性与可操作性。我国可根据药品治疗领域和疗效改善程度建立药品临床价值等级，作为药品医保准入决策的重要依据之一，减轻医保部门审评压力。药品临床价值等级的高低代表着药品治疗领域的重要性与疗效改善程度的大小，对于临床价值等级较高的药品，应当优先纳入基本医疗保险，以填补临床未满足的

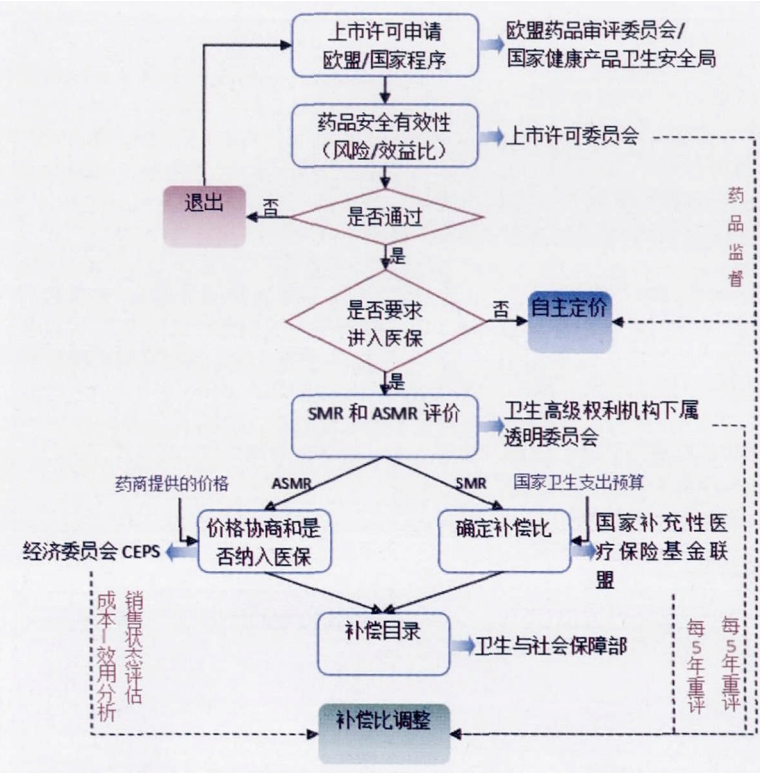


图 1　法国药品评价流程

表 3　不同评价结果下法国药品偿付标准或比例

评价结果	严重疾病	非严重疾病	增减范围
重大 *	65%	35%	上下 5% 浮动空间
中等 **	35%	35%	
较弱	35%	35%	
无附加效益	0	0	

* 示特例：30 种慢性高诊疗费疾病、部分严重疾病或并发症超过 6 个月的疾病 100%[4]；** 示特例：重新评估后待除名药品 15%。

表 4　ASMR 评级与定价原则

ASMR 等级	定价原则
ASMR I	自由定价（不高于四国外部参考价格）
ASMR II	可加价 20%
ASMR III	与市场同类药品价格相当
ASMR IV	降价 10%
ASMR V	降价＞ 30%

医疗需求，并在医保支付价格的制定或价格谈判时享有更多优势，而临床价值等级低的药品则限制性纳入或直接不予准入（表5）。

3.2　认识到临床价值等级的阶段性局限

表 5　药品临床价值等级在医保准入中的运用

医保准入方式	适用情况
直接准入	具有附加临床效益，具有经济性
谈判准入	具有附加临床效益，经济性不显著 临床价值等级高但有一定的临床不确定性
不予准入	附加临床效益低且不具有经济性 临床价值等级降低的药品

药监部门基于风险/效益比批准药品上市，对于附条件批准上市的药品还需要签订研究协议、明确责任义务，在真实世界下，药品风险放大、安全有效性进一步揭示，正是由于上市决策中存在的固有不确定性和药品上市后安全有效性特征持续更新，有必要基于真实世界的数据再次回顾药品的安全有效性，并对药品临床价值进一步调整与完善。法国TC正是根据新收集到的数据，每5年对SMR和ASMR进行重新评定，并据此调整医保决策。建议结合药品的持续研究结果、不良反应报告、Ⅳ期临床试验研究、新药监测、定期安全性更新结果、飞行检查结果、一致性评价结果等信息，根据药品新药监测与再注册周期，每5年进行药品临床价值等级的再评价，以逐步与其真实效果趋近，并将评价结果与药监部门、医保部门共享。对医保部门而言，根据临床价值等级的变更进行医保目录的动态调整，包括医保支付价格的变化、支付比例的变化，甚至退出医保目录。

参　考　文　献

[1] FRANKENA M. A comparative study of the role of disease severity in drug reimbursement decision making in four European countries[J]. Health policy, 2015(119):195-202.

[2] 沈秋欢. 药品参考价格制度典型国家创新药品定价与补偿机制[J]. 中国新药杂志，2017,26(14):1612-1617.

[3] SERMET C, ANDRIEU V, GODMAN B, et al. Ongoing pharmaceutical reforms in France: implications for key stakeholder groups[J]. Appl health econ health policy, 2010,8(1):7-24.

[4] 卢碧香，关轶茹，张方. 法国药品临床疗效和临床疗效改善评级管理及其借鉴启示[J]. 中国药物应用与监测，2018,15(2):113-117.

[5] SZERB A, KANAVOS P. Health technology assessment of cancer drugs in France and Germany: commonalities and differences in the value assessment of medical technologies[EB/OL]. (2015-01) [2018-09-18] http://www.lse.ac.uk/lse-health/assets/documents/working-paper-series/LSEHWP43.pdf.

[收稿日期：2019-02-14]（编辑：王笑笑）